SDD 269 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatre

Date : 02/02/2024
Auteur : ELAYLI Robin (DES Psychiatre, ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES Médecine interne, ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Education/prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	ITEM 66 TOC ITEM 78 Prescription de psychotrope
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 114 Anxiété SDD 136 TOC SDD 269 consultation de suivi et traitement de fond d'un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique (hors dépression)
Matériel nécessaire à la station	1 Bureau, 1 Chaises
Contexte de la station	Mise en place de traitement pour un TOC sévère résistant à la psychothérapie TCC

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous recevez Mr. Blâme, 34 ans, qui vous est adressé pour des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) de répétition dans un contexte de trouble du spectre autistique depuis 1 an , avec un impact très important au niveau familial, social et professionnel. Il bénéficie d'une psychothérapie depuis 8 mois, mais les TOC étant trop invalidants, le médecin traitant l'a redirigé vers vous. Vous posez le diagnostic de TOC sévère et vous vous apprêtez à prescrire un traitement pharmacologique pour les TOC et l'anxiété associée, médicament pour lesquels vous avez l'indication et l'absence de contre-indication.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer la classe pharmacologique adaptée à prescrire dans ce cadre
- Enoncer le traitement symptomatique adapté pour l'anxiété de ce patient
- Expliquer les traitements et les modalités de prise de ces traitements.

Vous ne devez pas :

- Examiner ou interroger la patiente
- Enoncer de dosage ou de nom précis de molécule
- Organiser une orientation ou prévoir un prochain RDV

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
Prescription faite		
Dit prescrire un inhibiteur de la recapture de la sérotonine (ISRS)	1 pt	☐
Dit prescrire une benzodiazépine	1 pt	☐
Education thérapeutique sur l'ISRS		
Explique que ce traitement est le traitement pharmacologique ou médicamenteux des TOC	1 pt	☐
Explique qu'il est nécessaire de prendre ce traitement tous les jours	1pt	☐
Explique que ce traitement a un délai avant d'être efficace	1 pt	☐
Dit que le délai dans le cadre du TOC est de 4 à 6 semaines	1 pt	☐
Énonce que les doses doivent être plus importantes dans le cadre d'un TOC		
Education théraeputique sur la benzodiazépine anxiolytique		
Explique que ce traitement est à but symptomatique pour calmer les anxiétés	1 pt	☐
Explique que la prise est en si besoin	1 pt	☐
Explique le risque d'addiction	1 pt	☐
Explique que la prescription de ce traitement est limité à 12 semaine maximum	1 pt	☐
Explique qu'il faut faire attention avec la prise d'alcool dans le cadre de ce traitement	1 pt	☐
Énonce qu'il faut prévoir l'arrêt du traitement avec le patient OU que le traitement ne doit pas être arrêté brutalement	1 pt	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication) — 1 pt ☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques) — 1 pt ☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**X points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

- Le traitement pharmacologique par excellence des TOCs sévères et envahissants sont les ISRS. Il est dans la pratique courante le plus souvent tenté une psychothérapie de type TCC seul en 1ère intention lorsque les TOCs reste léger à moyen en sévérité (vous n'avez pas à connaître les prises en charge de 1ère/2nd intention, juste à savoir que traitement TOC = TCC et/ou ISRS)

Les TOC sont cependant notables dans le traitements par ISRS par rapport aux troubles anxieux et dépressif par les aspects suivants :

Element	Trouble dépression	Trouble anxieux	TOC
Dosage	Souvent inférieur au 2 autres troubles	Souvent supérieur au trouble dépressif, mais moins que le TOC	Souvent plus (on dit souvent le double) que les troubles anxieux et dépressif
Durée d'évaluation d'efficacité	2 à 4 semaines		4 à 6 semaines
Fréquence de prise	Prise quotidienne		
Bilan pré-thérapeutique	Aucun normalement (sauf duloxétine = bilan hépatique)		

Information au programme de votre EDN	
Information pas au programme, donné en, complément (les ISRS étant un traitement souvent utilisé en médecin générale)	

Concernant les benzodiazépines,il est important lors de la prescription de verbalisé au patient :

- Le risque pour l'addiction
- Le risque pour la conduite automobile
- Proposer une prise plutôt en si besoin si possible que en systématique (on préfère qu'elle soit prise en cas d'anxiété plutôt que en systématique quotidiennement).
- Le délai maximum de prescription (12 semaine pour BZD anxiolytique ; 4 semaines pour les hypnotiques apparentés benzodiazépines)
- Le risque avec les consommations alcooliques (aussi présent dans les ISRS mais bien moins important et vous n'avez pas à le connaître pour les ISRS, que pour les benzo, et pour avoir testé, NE MÉLANGEZ JAMAIS BENZO ET ALCOOL, NE BUVEZ PAS D'ALCOOL LE JOUR OU VOUS PRENEZ DES BENZO)